

ANTIBIOTICO	FORMA DE ADMINISTRACIÓN			ESTABILIDAD
	Dosis de carga	Tiempo de perfusión	Preparación	
AMIKACINA		30 min	Vial reconstituido: 500mg/2mL(1000mg/ml) Diluir en 100 mL de SSF.	Estable 24h a 25°C Para SSF y SG a 25°C 48h
AMPICILINA		30 min	Reconstituir vial con 3ml API que viene con la ampolla Diluir en 50-100 de SF o SG5%	8h a 25°C
ANFOTERICINA B LIPOSOMAL		2horas	Reconstituir vial con 12 mL de API; agitar vigorosamente; extraer dosis e introducirla (utilizando filtro de 5 µm) en 250-500 mL de SG5%. (NO USAR SSF).	Estable 72h a 25°C 7 días 2-8°C
ANIDULAFUNGINA	200mg en 3horas	90 min	Reconstituir con 30 mL de API. Diluir en 100 mL de SSF.	Estable 48 h a 25°
AZTREONAM	2g en 30min	2-3 horas	Reconstituir vial con 4 mL de API. Diluir en 100 mL de SSF.	Estable 48h a 25°C 7d a 2-8°C (proteger de la luz)
CASPOFUNGINA	70mg	1 hora	Reconstituir con 10,5 mL de API o SSF. Diluir en 100-250 mL de SSF. NO USAR SG5% ni SGS.	Estable 24h a máximo 25°C. 48h a 2-8°C (proteger de la luz)
CEFAZOLINA		30 min	Reconstituir vial con 10 mL de API Diluir en 50-100 mL de SF o SG5%	24h a 25°C
CEFEPIMA	2g en 30 min	3-4 horas	Reconstituir vial con 10 mL de API o SSF. Diluir en 100 mL de SSF o SGS.	Estable 48h a 25°C
CEFIDEROCOL	2g en 30 min	3 horas	Para reconstituir un vial de 1 g extraer 10 mL de SF de la bolsa de 100mL. Para dosis de 2g extraer 20 mL de SSF o SG5%. Diluir en 100 mL de SSF o SG5%.	Vial reconstituido estable 1h a 25°C. Dilución (20mg/mL) estable 6h a 25°C, protegida de la luz>6h. Estable 24h a 2-8°C
CEFOTAXIMA		30 min	Reconstituir el vial con el mismo diluyente. Diluir en 50-100 mL SF o SG5%	
CEFTAROLINA		1-2 horas	Reconstituir vial con 20 mL de API. Diluir en 50-250 mL de SSF, SGS o SG5%	Estable 6h a 25°C 24h entre 2-8°C
CEFTAZIDIMA	2g en 30min	2-3 horas	Reconstituir vial con 10 mL de SSF. Diluir en 100 mL de SSF	Estable 24h a 25°C
CEFTAZIDIMA/ AVIBACTAM	2g en 30 min	2-3 horas	Reconstituir vial con 10 mL de API. Diluir en 100 mL de SSF	Dilución estable 12h a25°C, 24h a 2-8°C. Vial reconstituido debe utilizarse inmediatamente
CEFTOBIPROLE		2 horas	Reconstituir con 10 mL de API. Diluir en 250 mL de SSF	Vial reconstituido estable 1h a 25°C y 24h a 2-8°C. Dilución estable 24h a 25°C en SF, y 12h en SG5%. Estable 8h sin protección de la luz en SF y SG5%.Estable 96h a 2-8°C protegido de la luz
CEFTOLOZANO/ TAZOBACTAM	1-2g en 30 min	3 horas	Reconstituir vial con 10 mL de API o SSF. Diluir en 100 mL de SSF	Estable 24h a 25°C, 7 días refrigerada a 2-8°C
CEFTRIAXONA		30 min	Se reconstituye el vial con el mismo diluyente. Diluir en 50mL SF.Evitar diluyente que contengan Ca2+ NO USAR solución de Ringer lactato	Vial reconstituido 6h a 25°C Dilución 48h a 25°C
CEFUROXIMA		30 min	Reconstituir vial de 750mg con 6mL de API Diluir en 50-100mL de SF o SG5%	Vial reconstituido estable 5h a 25°C o 48h a 2-8°C
CLINDAMICINA		30 min	Diluir la dosis en 100-250 mL de SF o SG5%. Máximo 1200mg en una sola dilución	24h a 25°C
CLOXACILINA		1 hora	Reconstituir vial de 1g con 20 mL de API. Diluir en 50-100 mL de SSF.	Estable 24h a 25°C, 72h si refrigera.
COLISTINA	9MU	30 min	Reconstituir vial de 1MU con 2 mL de API Diluir en 100 mL de SSF	Una vez reconstituido y diluido en la bolsa debe utilizarse inmediatamente. A 2-8°C protegida de la luz estable 48h
DALBAVANCINA		30 min	Reconstituir cada vial con 25 mL de API. Diluir en 100-250 mL de SG5% (NO USAR SSF)	Estable 48h a 2-8°C y a 25°C

ANTIBIOTICO	FORMA DE ADMINISTRACIÓN			ESTABILIDAD
	Dosis de carga	Tiempo de perfusión	Preparación	
DAPTOMICINA		30 min	Reconstituir con SSF(350 mg/ 7mL: 500mg/10mL).Diluir en 100 mL de SSF. NO USAR SG5%.	Estable 12h a 25°C y 2-8°C
DELAFOXACINO		1 hora	Reconstituir el vial con 10,5 mL de SF o SG5%. Diluir en 250mL de SF o SG5%	Estable 24h a 25°C y 2-8°C
ERTAPENEM		30 min	Vía IV: Reconstituir vial con 10 mL de API o SSF. Diluir en 100 mL de SSF Vía IM: Reconstituir vial con 3mL de Lidocaína al 2%.	Estable 6h a 25°C y 24h a 4°C
FOSFOMICINA		3-4 horas	Reconstituir vial de 4g con 20 mL de API. Diluir en 50-250 mL de SG5%. (NO USAR SSF)	Estable 24h a 25°C y a 2-8°C
GENTAMICINA		30 min	Viene reconstituida. Diluir en 50-200mL de SF o SG5% y	Estable 48h a 25°C
IMIPENEM	1g en 30 min	3 horas	Reconstituir vial con 10 mL de SSF. Diluir dosis de 500 mg en 100 mL de SSF y 1g en 250 mL de SSF	Estable < de 4h a 25°C. 8h a 2-8°C
ISAVUCONAZOL		1 hora	Reconstituir vial de 200 mg con 5 mL de API. Diluir en 250 mL de SSF o SG5%. Utilizar equipo de perfusión con filtro en línea (tamaño poro 0,22 a 1,2 µm)	Estable 6h a 25°C, 24h a 2-8°C
LINEZOLID		1-2 horas	Viene diluido en 300 mL	Estable 4h a 25°C
MEROPENEM	1-2g en 30 min	3 horas	Reconstituir el vial 500 mg con 10 mL de API y 1g con 20 mL de API. Diluir en 100 mL deSSF o SG5%	Estable 4h a 25°C 24h entre 2-8°C. 10mg/mL 12h a 24° en SSF 20mg/mL 10h a 25°C
MEROPENEM/ VABORBACTAM	2g en 30 min	3 horas	Reconstituir cada vial con 20 mL extraídos de una bolsa de 250mL de SSF y diluir (concentración final de 4mg/mL).	4h a 25°C 22h a 2-8°C
MICAFUNGINA		1 hora	Reconstituir con 5mL de SSF lentamente y no AGITAR , para evitar formación de espuma.Diluir en 100 mL de SSF.	Estable 96h a 25°C con protección de la luz y 24h a 2-8°C
ORITAVANCINA		3 horas	Reconstituir cada vial de 400 mg con 40 mL de API y diluir en 1000mL deSG5%. Previamente sacar 120mL de una bola de 1000mL y coger 40mL de cada vial reconstituido (3 en total)hasta obtener una concentración de 1,2 mg/mL. (NO USAR SSF)	12h a 25°C y 24h a 2-8°C
PIPERACILINA/ TAZOBACTAM	4g en 30 min	4 horas	Reconstituir vial de 2g con 10 mL de API/SSF y 4g con 20mL de API/SSF. Diluir en 100 mL de SSF.	Estable 24h a 25°C
POSACONAZOL		90 min	Diluir contenido del vial (16,7 mL) en 250 mL de SSF.	Estable 24h a 2-8°C
RIFAMPICINA		3 horas	Reconstituir con 10 mL de API. Diluir en 500 mL de SG5%	Estable 4h a 25 °C, 24h 2-8°C, 8h a 25°C y 72h a 4°C
TEDIZOLID		1 hora	Reconstituir vial de 200 mg con 4 mL de API. Diluir en 250mL de SSF	Estable 24h a 25°C y a 2-8°C
TEICoplanina			Reconstituir el vial de 400 mg con 3 mL de API. Diluir en 100 mL de SSF	Estable 24h a 25°C y 24h a 2-8°C con protección de la luz.
TIGECICLINA	200mg	1 hora	Reconstituir vial con 5,3mL de SSF y agitar suavemente hasta conseguir disolución. Tomar 5mL de cada vial (el vial contiene un exceso de dosis del 6%). Diluir en 100mL de SSF	Una vez reconstituido y diluido en la bolsa debe utilizarse inmediatamente. 72h a 25°C y 14 días a 4°C con protección de la luz
TOBRAMICINA		30 min	Vial reconstituido. Diluir en 100mL de SSF	48h a 25°C o a 4°C.
VANCOMICINA		1 hora	Reconstituir vial con 20 mL de API. Diluir en 250 mL de SSF o G5%.	Estable 24h a 25°C, 48h a 25°C con protección de la luz, 7días a 2-8°C con protección de la luz.
VORICONAZOL		2-3 horas	Reconstituir vial con 19 mL de API. Diluir en 250 mL de SSF	Una vez reconstituido y diluido en la bolsa debe utilizarseinmediatamente Estable 24h a 2-8°C

VIOLETA: No compatible con RL	VERDE: Compatible con todo	GRIS: Ya viene diluido
AMARILLO: Sólo SF	ROSA: Compatible sólo SG5%	

OBJETIVOS

OPTIMIZAR LA EFICACIA en función del pK/pD de cada antimicrobiano:

Tiempo-dependientes(%fT>CMI): en BETALACTÁMICOS la perfusión extendida se asocia a mejores resultados, incluyendo mejor supervivencia.

Concentración-dependientes(C_{máx}/CMI): los AMINOGLUCÓSIDOS, QUINOLONAS, GLICOPÉPTIDOS Y LIPOPÉPTIDOS no se benefician de perfusiones extendidas.

---O---

DURACIÓN MÁXIMA DEL TRATAMIENTO "Shorter is better":

Pasado este tiempo valorar estrategias y/o contactar con experto PROA en el **699183/699182/120223**

Diagnóstico	Corto (días)
Neumonía adquirida en la comunidad (NAC)	3-5
NAC atípica	1
Posible Neumonía en UCI	1
Neumonía asociada a ventilación mecánica (NAVM)	5-8
Empiema	14-21
Exacerbación de Fibrosis Quística	10-14
ITU complicada/Pielonefritis	5 o 7
Infección intraabdominal	4
Apendicitis complicada	1-2
Bacteriemia (no S. aureus)	7
Celulitis/Infección de heridas/Abscesos	5-6
Osteomielitis	42
Osteomielitis en implantes	28
Osteomielitis diabética desbridada	10-21
Artritis séptica	14
Meningitis bacteriana (pediátrica)	4-7
AECB & Sinusitis	≤5
Hemorragia digestiva por varices esofágicas o gástricas	2-3
Fiebre neutropénica	AFx72h/3d
Profilaxis postoperatoria	0-1
Eritema migrans (Enfermedad de Lyme)	7-10
P. vivax Malaria	7
Sífilis temprana	1 IM

Basado en más de 140 Ensayos clínicos aleatorizados.

Fuente: <https://www.bradspiegelberg.com/shorter-is-better>

PLAN DE MEJORA EN LA ADMINISTRACIÓN DE ANTIMICROBIANOS

OBJETIVOS:

1. Optimizar la eficacia de los antimicrobianos en su uso para tratar infecciones, mejorando los resultados clínicos y microbiológicos.
2. Mejorar el perfil de toxicidad y reacciones adversas de los antimicrobianos.



HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES

Circuito para la solicitud de trasplante fecal oral a partir de la tercera recaída clínica en caso de infección por C difficile:

1. Constatar que se han realizado de forma correcta los tratamientos en los episodios previos.
2. Contactar con los miembros del PROA **699182/699183/120223** que valorarán el caso. Imprescindible realizar un informe clínico pormenorizado que incluya: las fechas de sintomatología, tratamientos y de las pruebas microbiológicas; junto con el consentimiento informado del paciente (se facilitará por parte del PROA).
3. Tras la aprobación del grupo PROA, el FEA responsable contactará con Farmacia para el trámite de uso compasivo a través de la Agencia Española de Medicamentos y Productos sanitarios. Persona de contacto: D. Meritxell Salazar.

---O---

SELLADO ANTIBIÓTICO DE CATÉTERES INTRAVENOSOS:

Contactar con servicio de farmacotecnia para indicaciones: **120497**

PARA LOS TRATAMIENTOS ANTIBIOTICOS > 5 DÍAS:

Contactar con la Unidad de accesos vasculares **603333**

TAMBIÉN PUEDES CONSULTAR LA GUÍA DE TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO DE ESTE HOSPITAL A TRAVÉS DE LA LANZADERA EN DIRAYA, EN EL PANEL DE APLICACIONES Y EN EL QR.

@: proa.hvn.sspa@juntadeandalucia.es

ⓧ @PROAHUVN



PROA - HUVN